NAVETA permite una evaluación estandarizada y centrada en el paciente con PROMs, aportando información clave para personalizar la atención y mejorar resultados en salud.

SEOM 2025
Madrid 11 - 14 Noviembre

Calidad de Vida Relacionada con la Salud en pacientes oncológicos: un estudio piloto en cáncer de pulmón, próstata y mama.

Autores: Francisco Javier Jiménez Ruiz[1], Gabriel Mercadal-Orfila[2], Ignacio Blasco Mascaró[2], Rocío Romero Del Barco[2], Jorge Gracia-Calvo Navarro[2] & Salvador Herrera-Pérez[3]

[1]S Oncologia . H Mateu Orfila; [2]S Farmacia. H Mateu Orfila [3]Facultad de ciencias de Salud- Universidad Internacional de Valencia

1 Introducción

Los PROMs permiten captar el impacto real del cáncer y sus tratamientos desde la perspectiva del paciente. NAVETA ha implementado un sistema estructurado de recogida de PROMs en tumores de mama, próstata y pulmón, integrando esta información en la atención oncológica para mejorar la toma de decisiones y la calidad asistencial.

2 Objetivo

valuar la viabilidad y utilidad clínica de un sistema estructurado de recogida de PROMs en pacientes con cáncer de mama, próstata y pulmón, como herramienta para mejorar la atención personalizada y la calidad asistencial.

3 Métodos

Se realizó un estudio piloto observacional, multicéntrico y prospectivo en pacientes con cáncer de mama (n=37), próstata (n=39) y pulmón (n=6) incluidos en la plataforma NAVETA, con una ventana de observación de hasta 24 meses. Se recogieron variables sociodemográficas, clínicas, efectos adversos y resultados de cuestionarios PROMs. El comité científico de NAVETA definió un conjunto específico de PROMs para cada patología: en cáncer de próstata se aplicaron EPIC-16, EORTC QLQ-PR25 y QLQ-C30; en cáncer de mama, BREAST-Q, EORTC QLQ-BR23 y FACT-ES; y en cáncer de pulmón, EORTC QLQ-LC13 y QLQ-C30. Además, se utilizaron herramientas transversales como PROMIS-29, TSQM, MST, WRFQ y PRO-CTCAE. El análisis estadístico incluyó pruebas no paramétricas (Kruskal-Wallis), test de Dunn y correlaciones de Spearman para explorar diferencias y asociaciones entre dominios de los PROMs.

4 Resultados

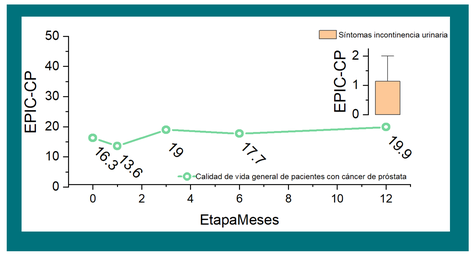

Fig.1: Evolutivo EPIC-CP. En pacientes con cáncer de próstata, las puntuaciones del EPIC-CP-16 indicaron una afectación leve-moderada de la calidad de vida general a lo largo del seguimiento (rango 13–24), con variaciones leves entre los distintos momentos. La incontinencia urinaria se mantuvo estable y sin impacto clínicamente relevante, con puntuaciones medias consistentemente inferiores a 2.

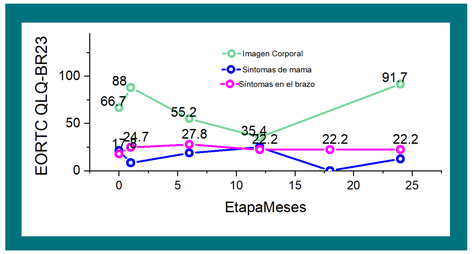

Fig. 2. **Evolución de la calidad de vida y síntomas en pacientes con cáncer de mama**: En pacientes con cáncer de mama, la imagen corporal (EORTC QLQ-BR23) mostró una mejora inicial en el primer mes, seguida de un deterioro progresivo hasta el mes 12. Los síntomas mamarios mejoraron inicialmente, pero aumentaron nuevamente en etapas posteriores. Los síntomas en el brazo mostraron un empeoramiento sostenido a lo largo del seguimiento.

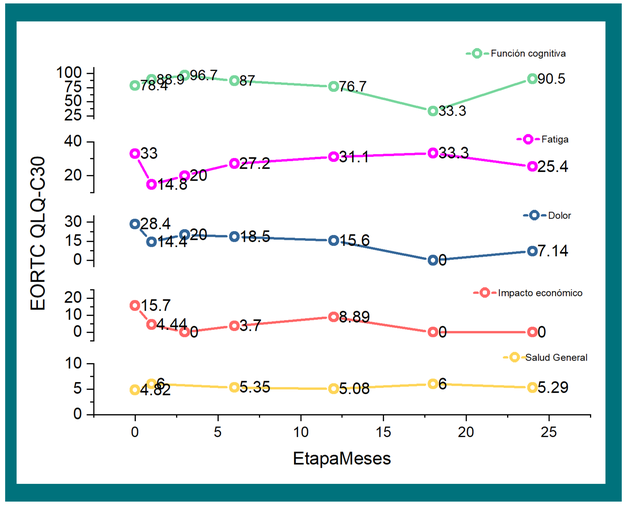

Fig. 3. Evolución de la calidad de vida y síntomas en pacientes con cáncer de pulmón: En pacientes con cáncer de pulmón, la función cognitiva (EORTC QLQ-C30) mostró una mejora sostenida durante el seguimiento, salvo una caída puntual en el mes 18. También se observaron mejoras en fatiga, dolor e impacto económico, con valores que se mantuvieron bajos o en reducción hasta el mes 24. Sin embargo, la calidad de vida global se mantuvo en niveles bajos durante todo el periodo de observación.

5 Conclusiones

NAVETA permite una evaluación longitudinal y centrada en el paciente con PROMs, útil para personalizar la atención clínica., con potencial para guiar la toma de decisiones clínicas personalizadas.

6 Agradecimientos

Extendemos nuestro agradecimiento a todos los pacientes que amablemente han permitido la inclusión de sus datos anónimos, así como a los profesionales sanitarios que han contribuido al proyecto ALGOPROMIA.

7 Referencias

El modelo NAVETA se puede consultar en: Mercadal-Orfila G, Herrera-Pérez S, Piqué N, Mateu-Amengual F, Ventayol-Bosch P, Maestre-Fullana MA, Serrano-López de Las Hazas JI, Fernández-Cortés F, Barceló-Sansó F, Rios S. Implementing Systematic Patient-Reported Measures for Chronic Conditions Through the Naveta Value-Based Telemedicine Initiative: Observational Retrospective Multicenter Study. JMIR Mhealth Uhealth. 2024 Jun 28;12:e56196. doi: 10.2196/56196

8 Información de contacto

Francisco Javier Jiménez Ruiz·
franciscojavier.jimenez@hgmo.es